

# Relatório de Progresso e Escopo - Clínica Médica

---

**Data de Atualização: 11 de Setembro de 2026 às 20:30**

**Data de Atualização: 07 de Setembro de 2026**

## 1. Status da Sprint e Integração (GitHub)

A etapa de modelagem física e criação das tabelas foi concluída, contemplando profissionais de saúde, pacientes, contatos de emergência, prontuários, evoluções clínicas, consultas, medicamentos e prescrições. As doze tabelas e suas restrições de integridade foram definidas com base nas 21 regras de negócio estabelecidas para o projeto.

## 2. Regras de Negócio (Artefato A1)

Lista organizada por categorias com as 21 travas lógicas validadas e rastreáveis para o domínio da clínica:

### Gestão de Profissionais

1. O CPF dos profissionais de saúde deve possuir exatamente 11 caracteres numéricos e não pode ter duplicidade no sistema.
2. Todo médico registrado no banco deve possuir um número de CRM único e de preenchimento obrigatório.
3. Todo enfermeiro registrado deve possuir um registro COREN único e de preenchimento obrigatório.
4. A exclusão de um registro base de Profissional de Saúde deve forçar a exclusão automática de sua especialização (Médico ou Enfermeiro) para evitar dados órfãos.
5. A demissão ou exclusão de um médico supervisor não deleta os médicos residentes vinculados a ele, apenas redefine o campo de supervisão para nulo.

### Gestão de Pacientes e Contatos

6. O número de CPF do paciente é de preenchimento obrigatório e deve ser estritamente único.
7. Um contato de emergência não possui identificação independente e só pode ser registrado se vinculado a um paciente existente.
8. A exclusão do cadastro de um paciente obriga o banco a deletar em cascata todos os contatos de emergência associados a ele.

## **Histórico Clínico**

9. Cada paciente pode possuir no máximo um prontuário, garantindo uma relação 1:1 entre Paciente e Prontuário.
10. O tipo sanguíneo documentado no prontuário deve pertencer exclusivamente à lista de domínios biológicos válidos (A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-).
11. A exclusão manual de um prontuário base exclui automaticamente todo o histórico de evoluções clínicas atrelado a ele.
12. O registro de um profissional de saúde não pode ser apagado se ele já for o responsável por assinar alguma evolução clínica.
13. Toda alteração relevante na situação clínica de um paciente deve manter um registro histórico contendo obrigatoriamente a data da ocorrência, não sendo permitido substituir registros anteriores sem manter seu histórico.

## **Atendimentos, Prescrições e Medicamentos**

14. Toda consulta deve estar obrigatoriamente vinculada a um paciente existente e a um médico existente.
15. A data e o horário de realização da consulta são campos obrigatórios.
16. Um mesmo médico não pode possuir duas consultas cadastradas para a mesma data e horário.
17. O valor financeiro cobrado por uma consulta não pode ser inferior a zero.
18. O cancelamento e exclusão de uma consulta deve limpar em cascata todas as prescrições de medicamentos atreladas a ela.
19. Todo medicamento cadastrado deve possuir nome obrigatório, não sendo permitido o cadastro sem identificação.
20. Um medicamento pode ser prescrito em várias consultas e uma consulta pode possuir vários medicamentos prescritos, sendo cada prescrição responsável por armazenar informações como dosagem e frequência.

## **Especialidades Médicas**

21. Um médico pode possuir várias especialidades, e uma especialidade pode estar vinculada a vários médicos. Para cada vínculo entre médico e especialidade deve ser registrada obrigatoriamente a data de obtenção da especialidade.

